Nome: NOEMIA DA SILVA FONTENELE
Código: 19356-2
Idade: 64 anos 3 meses
Sexo: FEMININO
Data: 28/12/2023 09:50:03

CLÍNICA SANTA MARIA

Duplex Scan Colorido do Sistema Venoso do Membro Inferior Esquerdo

Qualidade técnica: Adequada

Foram avaliados os seguintes vasos: veia femoral comum, veia femoral superficial, veia femoral profunda, veia poplítea, veias tibiais, veias fibulares, veia safena magna e veia safena parva.

Membro Inferior Esquerdo

Sistema venoso profundo:
As veias profundas apresentam-se pérvias, compressíveis, com fluxo modulado pelos movimentos respiratórios. Observa-se resposta fisiológica às manobras de compressão e descompressão das massas musculares subjacentes e à manobra de Valsalva. Não se observam sinais de trombose venosa profunda.

Sistema venoso superficial:
- Junção safeno-femoral pérvia e competente.
- Presença de refluxo segmentar em veia safena magna a partir de 15cm abaixo da junção (segmento em que está superficializada) até nível de interlinha 'J", drenando por tributárias varicosas. Não visibilizada em 1/3 proximal de perna (status pós operatório ?). Demais segmentos pérvios e competentes em coxa e perna.
- Presença de tributárias varicosas em coxa e perna.
- Refluxo segmentar em veia safena parva desde junção na interlinha 'J" (apresenta extensão cranial) até aproximadamente 9cm distalmente, drenando por tributárias varicosas. Não visibilizada em 1/3 médio e distal (status pós operatório/hipoplásia ?)

Safena magna (diâmetros):
JSF: 4,6 mm CP: 3,1 mm CD: 3,4 mm PP: X mm PD: 1,4 mm

CONCLUSÃO:

1) ***Junção safeno femoral pérvia e competente;***
2) ***Refluxo segmentar em veia safena magna;***
3) ***Refluxo segmentar em veia safena parva;***
4) ***Tributárias varicosas em coxa e perna;***
5) ***Sistema venoso profundo pérvio e competente.***

Dr. Lucas de Freitas
Cirurgia Vascular Endovascular e Ecodoppler
CRM-MA 5753 RQE 21
RQE 4261

Nome: NOEMIA DA SILVA FONTENELE
Código: 19356-2
Idade: 64 anos 3 meses
Sexo: FEMININO
Data: 28/12/2023 09:50:03

CLÍNICA SANTA MARIA

Duplex Scan Colorido do Sistema Venoso do Membro Inferior Direito

Qualidade técnica: Adequada

Foram avaliados os seguintes vasos: veia femoral comum, veia femoral superficial, veia femoral profunda, veia poplítea, veias tibiais, veias fibulares, veia safena magna e veia safena parva.

Membro Inferior Direito

Sistema venoso profundo:

As veias profundas apresentam-se pérvias, compressíveis, com fluxo modulado pelos movimentos respiratórios. Observa-se resposta fisiológica às manobras de compressão e descompressão das massas musculares subjacentes e à manobra de Valsalva. Não se observam sinais de trombose venosa profunda.

Sistema venoso superficial:

- Junção safeno-femoral pérvia e competente.
- ***Presença de refluxo segmentar em veia safena magna desde logo após junção até 10cm distalmente, drenando por tributárias varicosas. Não visibilizada em 1/3 proximal de perna (status pós operatório ?). Demais segmentos pérvios e competentes em coxa e perna.***
- ***Presença de tributárias varicosas em coxa e perna.***
- Veia safena parva pérvia e competente.
- Não visualizadas perfurantes insuficientes.

Safena magna (diâmetros):
JSF: 5,8 mm CP: 2,9 mm CD: 2,5 mm PP: x mm PD: 2,1 mm

CONCLUSÃO:

1) ***Junção safeno femoral pérvia e competente;***
2) ***Refluxo segmentar em veia safena magna de coxa;***
3) ***Veia safena parva pérvia e competente;***
4) ***Tributárias varicosas em coxa e perna;***
5) ***Sistema venoso profundo pérvio e competente.***

Dr. Lucas R. de Freitas
Cirurgia Vascular, Endovascular e Ecodoppler
CRM-MA 5755/RQE 3121
RQE 4258 RQE 4255

LUCAS RODRIGUES FREITAS
CRM-MA: 5755

CTR
Medicina Diagnóstica

Nome: NOEMIA DA SILVA FONTENELE, 64 A
Médico: MARCOS FERNANDES MARINHO
Convênio: SUS-CO
Protocolo: 2264962 **Data:** 20/05/2024
Senha: 1021623

TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA LOMBAR

TÉCNICA:
Exame realizado através de cortes axiais, espirais, multidetectores de 0,6 mm de colimação e incremento, sem administração venosa do meio de contraste e processadas reformatações MIP, MPR e 3D.

RESULTADO:
Retificação da lordose lombar fisiológica.
Redução do espaço intersomático no nível de L5-S1, com presença de focos de gás intra discal.
Abalamento discal assimétrico no nível de L5-S1, assimétrico, maior à esquerda, reduzindo a amplitude do respectivo forame neural.
Artrose interapofisária nos níveis de L3-L4 a L5-S1, mais evidente no nível de L3-L4 à direita.
Osteófitos marginais nos corpos inferiores vertebrais.
Eixo lombar preservado.
Corpos vertebrais alinhados, de altura preservada.
Pedículos íntegros.
Demais espaços intersomáticos preservados.
Canal raquiano e demais forames neurais de amplitude normal.

Dr. Pedro Victor de Lima Leite e Silva
Radiologia e Diagnóstico por Imagem
CRM: 7722 – MA

NOTA
O Ministério da Saúde, em conjunto com as sociedades médicas brasileiras, orientou a racionalização do uso de contraste iodado para exames e procedimentos médicos, até que o fornecimento do insumo seja normalizado segundo nota de 22/07/2022 disposta no site www.gov.br. Devendo inclusive, a critério do Médico solicitante e do Médico Radiologista em entendimento mútuo, substituir ou complementar por outros métodos propedêuticos com acurácia diagnóstica semelhante (ultrassonografia, ressonância magnética ou de medicina nuclear).
Para maiores esclarecimentos e interação entre o Médico solicitante e o Radiologista, a CTR disponibiliza o canal Fale com o Radiologista através do nosso site www.ctr.med.br ou pelo WhatsApp (98) 99157-9075.

CTR
Medicina Diagnóstica

Nome: NOEMIA DA SILVA FONTENELE, 64 A
Médico: MARCOS FERNANDES MARINHO
Convênio: SUS-CO
Protocolo: 2264962 **Data:** 20/05/2024
Senha: 1021623

TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA LOMBAR

TÉCNICA:
Exame realizado através de cortes axiais, espirais, multidetectores de 0,6 mm de colimação e incremento, sem administração venosa do meio de contraste e processadas reformatações MIP, MPR e 3D.

RESULTADO:
Retificação da lordose lombar fisiológica.
Redução do espaço intersomático no nível de L5-S1, com presença de focos de gás intra discal.
Abalamento discal assimétrico no nível de L5-S1, assimétrico, maior à esquerda, reduzindo a amplitude do respectivo forame neural.
Artrose interapofisária nos níveis de L3-L4 a L5-S1, mais evidente no nível de L3-L4 à direita.
Osteófitos marginais nos corpos inferiores vertebrais.
Eixo lombar preservado.
Corpos vertebrais alinhados, de altura preservada.
Pedículos íntegros.
Demais espaços intersomáticos preservados.
Canal raquiano e demais forames neurais de amplitude normal.

Dr. Pedro Victor de Lima Leite e Silva
Radiologia e Diagnóstico por Imagem
CRM: 7722 – MA

NOTA:
O Ministério da Saúde, em conjunto com as sociedades médicas brasileiras, orientou a racionalização do uso de contraste iodado para exames e procedimentos médicos, até que o fornecimento do insumo seja normalizado segundo nota de 22/07/2022 disposta no site www.gov.br. Devendo inclusive, a critério do Médico solicitante e do Médico Radiologista em entendimento mútuo, substituir ou complementar por outros métodos propedêuticos com acurácia diagnóstica semelhante (ultrassonografia, ressonância magnética ou de medicina nuclear).
Para maiores esclarecimentos e interação entre o Médico solicitante e o Radiologista, a CTR disponibiliza o canal Fale com o Radiologista através do nosso site www.ctr.med.br ou pelo WhatsApp (98) 99157-9075

Estamos à disposição!

TR - DOM LAGOA
a Lótus, nº 07, Qd. 01 - 2º andar
dim Renascença, CEP: 65075-480

R - Centro
lado da Santa Casa)
a do Norte, nº 420
ntro, CEP: 65015-330

CTR - Unidade DOM Cohajap
Av. Daniel de La Touche, 5620
Cohajap - São Luís - MA, 65045-250

CTR - Cidade Operária
(Prédio Medical Cidade Operária)
Av. Lourenço Vieira da Silva/Av. 203,
Qd. A, nº 2 - Cidade Operária,
CEP: 65058-213

CTR - HCI
Angelim
Av. Jerônimo de Albuquerque, nº 1800
(ao lado da Norte Refrigeração)

CTR - Pinheiro
Praça José Sarney, 351
Centro - Pinheiro (MA)
(98) 2107-2727 (98) 9207-1696

SAC2
(98) 2107
www.ctr.med.b
www.domsauc
@ctr-ma
Siga-nos nas re